암 생존자 공동관리 치료력에서 시작

암 생존자 공동관리: 치료력으로 찾는 후기 합병증

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

생존자 관리는 다섯 축으로 이어진다

치료 종료 뒤의 건강관리는 재발 검사만을 뜻하지 않는다

재발 감시

증상·병력·진찰을 중심으로 종양내과 추적 일정과 연계한다.

이차암 선별

연령별 검진을 기본으로 치료력·유전성 위험을 반영한다.

장기·후기 독성

어떤 치료를 받았는지부터 확인해 늦게 나타나는 독성을 추적한다.

생존자 관리

건강증진·예방접종

생활습관, 동반 만성질환과 예방의료를 관리한다.

심리사회적 지지

심리사회적 지지와 진료 조율도 생존자 관리에 포함한다.

동년배 일반인에 준한 건강관리 위에 암·치료 이력을 겹쳐 본다.

재발 감시는 새 증상과 기존 일정이 중심

무증상 검사 확대보다 암 종류·치료·경과를 반영한다

기본 원칙

재발 위험은 암 종류·기존 치료·경과 기간에 따라 다르다. 새 증상은 즉시 평가하고 치료 병원의 추적 일정과 진료를 조율한다.

검사의 역할

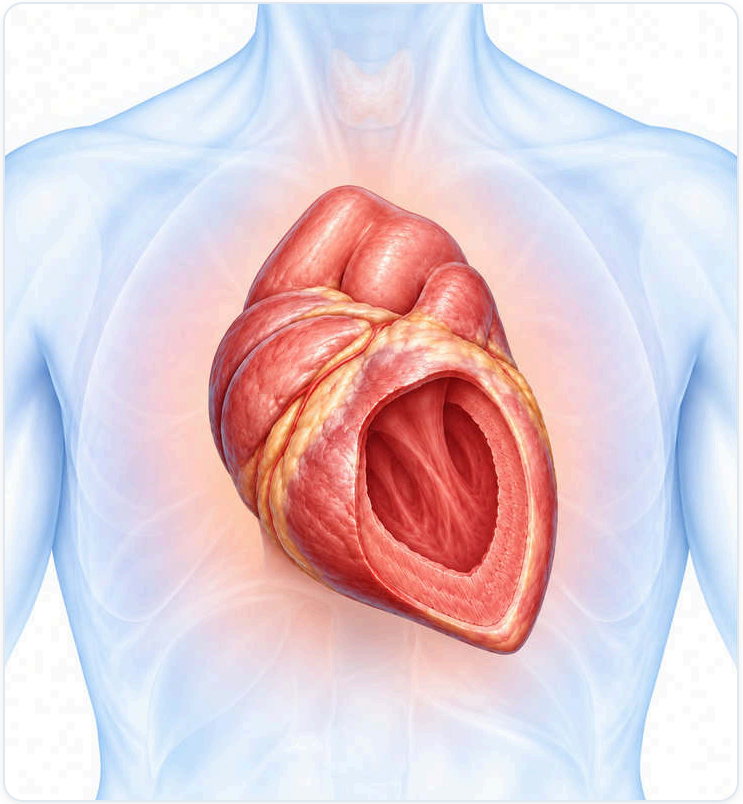
무증상 환자의 정기 전신영상·종양표지자는 대부분 이득이 없다는 원칙을 설명했다. 유방암은 매년 유방촬영, 6개월 간격 문진·진찰을 별도로 제시했다.

체중감소·지속 뼈통증·두통·신경학적 이상·출혈은 지체 없이 평가·의뢰하는 단서다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

치료력을 후기 위험·추적으로 바꾼다

강의 표의 심혈관·흉부 방사선치료 두 행

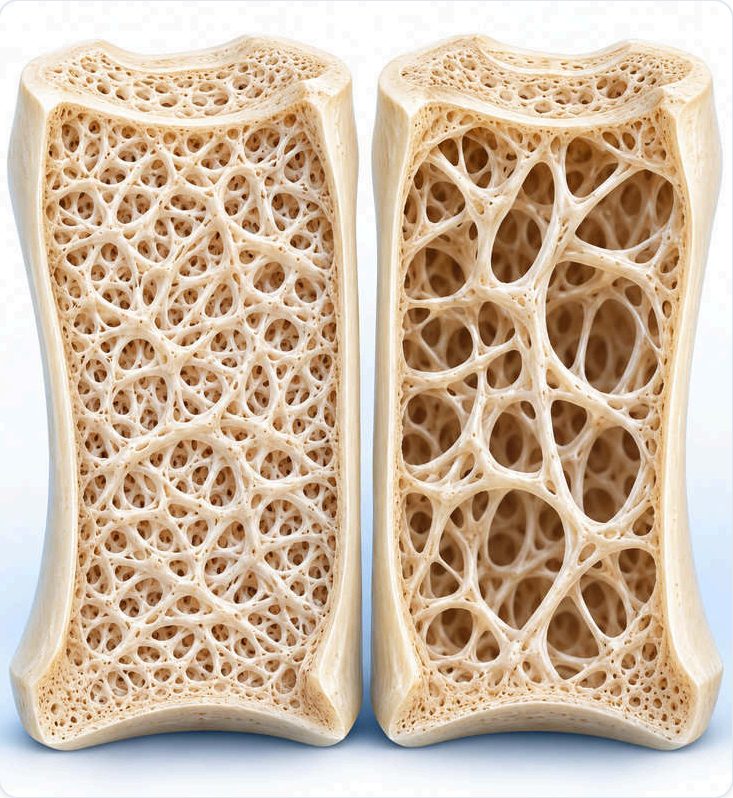


치료력	후기 위험	개원가 추적
안트라사이클린 / 트라스투주맙	심근병증·심부전 (수년 뒤도)	증상 문진·혈압, 필요 시 심초음파 ·NT-proBNP, 심장내과 연계
흉부 방사선치료	심혈관질환·이차암· 갑상선기능저하	혈압·지질·TSH, 관련 부위 진찰

> 치료가 끝난 지 수년 뒤라도 호흡곤란·부종·운동능력 저하를 놓치지 않는 것이 중요하다.

내분비 치료력은 골건강과 연결한다

강의 표의 아로마타제 억제제·난소기능 억제 두 행



치료력	후기 위험	개원가 추적
아로마타제 억제제	골소실·골절, 관절통, 지질 상승	골밀도(DXA), 지질, 칼슘·비타민D
난소기능 억제 / 조기폐경	골소실, 혈관운동·비뇨생식 증상	골밀도(DXA), 증상 관리

강의는 유방암 호르몬치료 뒤 골밀도 감소와 골다공증을 일차 진료에서 살필 합병증으로 설명했다.

신경독성과 내분비 독성은 늦게도 남는다

강의 표의 백금계·탁산과 면역항암제 두 행

치료력	후기 위험	개원가 추적
백금계 / 탁산	말초신경병증(잔존)	증상 문진, 낙상 예방 교육
면역항암제(ICI) 경험자	지연성 내분비병증(갑상선·부신 등)	TSH, 필요 시 코르티솔·혈당, 증상 시 의뢰

> 말초신경병증이 4~5년 뒤에도 남거나, 면역치료 종료 1~2년 뒤 내분비 증상이 나타날 수 있다고 설명했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이차암 선별은 일반 검진에 치료력을 더한다

위험 요인에 따라 선별과 유전상담을 연결한다

일반 검진

이차암 선별은 연령을 고려한 국가검진·일반 인구 기준을 기본으로 진행한다.

흉부 방사선 후

강의 표에서는 유방·폐 등 치료력에 맞춘 추가 선별을 제시했다.

골반 방사선 후

강의 표에서는 대장 등 관련 장기의 추가 선별을 제시했다.

유전성 위험

BRCA 등 유전성 위험이 확인되면 해당 장기의 강화 선별·유전상담과 연결한다. 유전성 클리닉 추적도 확인한다.

재발 감시와 새로운 암의 선별은 목적이 다르므로 각각의 계획을 확인한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

개원가 검사도 목적과 치료력에 맞춘다

강의의 추적 검사 범주를 일차 진료에 연결한다

혈액	CBC, 대사·간·신장 기능, 지질, 공복혈당·HbA1c, TSH, 칼슘·비타민D
심혈관	혈압·심전도, 필요 시 심초음파·NT-proBNP와 심장내과 연계
골건강	골밀도(DXA): 내분비요법·조기폐경 환자에서 주기적으로 평가
영상·국가검진 연계	유방촬영, 위·대장내시경, 해당 시 저선량 흉부 CT, 자궁경부 검사

> 검사 항목을 한꺼번에 확대하기보다 암 치료 이력·증상·선별 목적에 맞춰 진료를 조율한다.

일차 진료는 건강증진과 동반질환을 잇는다

암 치료 종료 뒤에도 예방의료는 계속된다



생활습관

금연·절주, 규칙적 운동과 체중 관리를 설명한다.

만성질환

혈압·혈당·지질 등 일반 내과 동반질환을 관리한다.

골건강·예방접종

골건강을 챙기고 예방접종을 최신화한다. 교재는 불활성화 백신 권장과 생백신의 면역상태 평가를 구분했다.

진료 조율

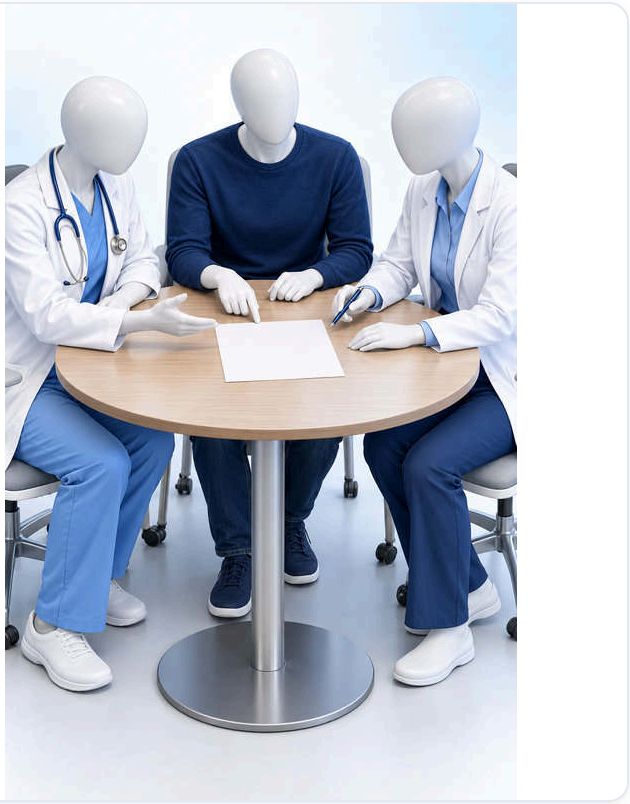
안정적 생존자의 검진 연계·심리사회적 지지와 치료 병원 추적을 이어간다.

> 안정적 장기생존자의 일반 건강관리는 일차 진료의 중요한 역할이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

상급병원과 일차 진료의 역할을 나눈다

환자의 현재 단계와 문제의 성격으로 연결한다



상급병원이 맞는 경우

진단·병기·전신치료 방침 결정, 활성 항암·면역치료의 독성·반응 평가, 임상시험 참여, 새 전이·합병증·종양응급, 복잡한 다학제 결정.

일차 진료에서 가능한 경우

안정적 장기생존자의 일반관리·검진 연계, 경한 부작용·수분·증상관리, 고혈압·당뇨·이상지질 관리, 백신·골건강·금연 등 예방의료.

일차 진료에서 관리하되 위험 신호를 알고 적시에 의뢰하는 것이 강의의 역할 분담이다.

새 증상은 기존 치료력과 함께 즉시 평가

종양학적 응급 상황을 일차 진료에서 놓치지 않는다

척수압박

새로 악화된 등통증, 하지 위약·감각 이상, 배뇨·배변 장애는 응급 평가·의뢰 단서다.

고칼슘혈증

다음·다뇨·오심·혼돈·무기력. 보정칼슘을 평가하고 강의는 수액을 시작하며 의뢰하는 접근을 설명했다.

상대정맥증후군

얼굴·목 부종, 경정맥 팽대, 호흡곤란·기침·두통을 살핀다.

종양용해증후군

고칼륨·고인산·고요산·저칼슘·신손상의 조합. 큰 종양 치료 초기에 연계가 필요하다.

발열성 호중구감소

항암 중 발열은 이를 의심하고 즉시 의뢰한다. 강의는 첫 항생제 1시간 목표를 제시했다.

출혈·혈전

조절되지 않는 출혈, 새 호흡곤란·하지부종 등 폐색전·심부정맥혈전 의심 증상을 의뢰한다.

> 증상이 새로 생겼다는 사실은 치료 종료 후 경과 기간과 무관하게 진료 연결의 중요한 단서다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

치료명에서 후기 위험과 진료 계획으로

강의 표의 여섯 치료력을 빠뜨리지 않고 인계한다

치료력 파악

안트라사이클린·트라스투주맙, 흉부 방사선, 아로마타제 억제제, 난소기능 억제·조기폐경, 백금계·탁산, 면역항암제 경험을 확인한다.

증상·검사 연결

심혈관·갑상선, 골·지질·폐경 증상, 지속 말초신경병증과 지연 내분비병증을 연결해 추적한다.

진료 조율

재발 감시 일정과 이차암 선별을 확인하고, 일상 건강관리와 새 증상·응급 의뢰를 분담한다.

치료 종료 수년 후에도 독성이 나타날 수 있다는 관점으로 병력을 이어받는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의의 핵심을 진료의 연결점으로

암 생존자 공동관리: 치료력으로 찾는 후기 합병증

치료력 파악

안트라사이클린·트라스투주맙, 흉부 방사선, 아로마타제 억제제, 난소기능 억제·조기폐경, 백금계·탁산, 면역항암제 경험을 확인한다.

증상·검사 연결

심혈관·갑상선, 골·지질·폐경 증상, 지속 말초신경병증과 지연 내분비병증을 연결해 추적한다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,

4층 402-404호

031-893-4560

강의 학습자료 다시 보기

> 치료 종료 수년 후에도 독성이 나타날 수 있다는 관점으로 병력을 이어받는다.